No. **No existe evidencia de que baxdrostat reduzca la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca (IC)**; se ha estudiado principalmente para **hipertensión resistente/no controlada**, no como tratamiento de la IC.mdpi+1

Qué se sabe hasta ahora

Baxdrostat es un inhibidor selectivo de la aldosterona sintasa (CYP11B2), diseñado para disminuir la producción de aldosterona y reducir la presión arterial. Los ensayos publicados —incluidos BrigHTN y HALO— evaluaron descensos de presión arterial en hipertensión resistente o no controlada, no desenlaces de mortalidad en IC.mdpi+1

En un metaanálisis de inhibidores de la aldosterona sintasa en hipertensión, no se observó diferencia en mortalidad por cualquier causa frente a placebo (OR 0,45; IC 95 % 0,06–3,20), aunque el intervalo fue muy amplio y los estudios no tenían potencia para valorar mortalidad.linkinghub.elsevier

Por qué la pregunta es razonable

El exceso de aldosterona se relaciona con fibrosis, inflamación, daño cardiovascular y renal, por lo que inhibir su síntesis podría teóricamente beneficiar a algunos pacientes con IC. Sin embargo, esa posibilidad biológica **no equivale a beneficio clínico demostrado**; los antagonistas del receptor mineralocorticoide sí tienen evidencia de reducción de mortalidad en fenotipos seleccionados de IC, pero baxdrostat actúa por un mecanismo distinto y no ha completado ese programa de evaluación.journals.lww+1

Implicación práctica

- **No** debe asumirse que baxdrostat mejora la supervivencia en IC.
- Su uso actual se centra en **hipertensión resistente**, con reducciones de presión arterial frente a placebo en varios ensayos.mdpi+1
- Los riesgos relevantes incluyen **hiperpotasemia, hiponatremia e hipotensión**, aspectos especialmente importantes si coexiste IC, enfermedad renal o tratamiento con IECA/ARA-II/ARNI o espironolactona.linkinghub.elsevier

En resumen: baxdrostat es prometedor para hipertensión resistente, pero **aún no hay ensayos que demuestren reducción de mortalidad en insuficiencia cardíaca**.